

病人目前的病況**需要留在醫院治療。**

目前本院病房無空床，只能先留在急診治療，排隊等病房住院。

- **甚至，現在急診也沒有床位可躺。**若有新的空床，會按照病情嚴重度和等候順序分配。
- **等病房時間為 平均 4 天，最長 8 天。**
- 根據衛生福利部公開統計的資料（急診轉住院暫留急診超過四十八小時案件比率），本院為急診等住院壅塞程度較高的醫院。

您需要知道，**在急診暫留越久，病人的死亡率、併發症和譫妄的風險越高。**

- 每增加 1 小時急診暫留時間，院內心跳停止死亡的風險增加 10%
- 每增加 1 小時急診暫留時間，譫妄（腦部認知功能失調）或嚴重躁動的發生風險增加 2%

您應該考慮：

選項一：本院與合作醫院的病房有合作的住院綠色通道，平日白天可直接從本院急診至合作醫院的病房住院。若有意願，可向醫師提出，評估病況是否適合。

選項二：**轉院**到其他醫院的急診。

- 轉院一律是到其它醫院的急診等病房。沒有辦法預先知道其它醫院要等多久才有病房。只能說根據統計資料，本院是全國等最久。
- 附近的醫院及其「急診轉住院暫留急診超過四十八小時案件比率」供參考：
 - 附近各醫院的「急診轉住院暫留急診超過四十八小時案件比率」，請參考衛生福利部公開統計數據。
 - 附近各醫院的「急診轉住院暫留急診超過四十八小時案件比率」，請參考衛生福利部公開統計數據。
 -
 -
 -
 -

若您因個人因素，**堅持不願意**留在醫院治療，可要求“**不遵醫囑自動出院**”。

需簽署切結書，自負風險。

我們依然會為你開口服藥、預約門診回診追蹤。

若您選擇留在本院治療，請配合以下規則：

- 會給你住院登記單，到急診一進門口的掛號櫃檯登記排隊等住院。
- **先留在急診治療，排隊等病房住院。**
- 若治療反應良好，過幾天病況迅速改善，就會從急診直接離院回家。
- 若仍需持續治療，且病房有新的空床釋出（病房病人出院或過世），就會上去病房住院。
- **現在急診也沒有床位可躺。**若有新的空床，會**按照病情嚴重度和等候順序分配**。若目前無床可躺，請耐心等候。
- 病人過多時，我們會縮窄床位間距，在兩張床位中插入病床，敬請諒解。
- 急診沒有枕頭。

- 與全台灣任何急診或病房相同，急診病人需要一位家屬/看護 24 小時陪同照顧（購買食物、協助如廁、更換尿布、翻身）。若您想請看護，請自行聯絡仲介公司
- 請務必將每次醫護人員的病情解釋，轉達交代給所有家屬知道。
- 請將病人長期服用的慢性病藥物，從家中帶來醫院，交給醫護人員檢查，確定以現在的病況而言，是否應繼續服用。
- 因感染控制考量，病人本人不能離開急診，到 B1 美食街。請家屬/看護協助購買食物上來吃。